

Pamięć *traumatyczna*

Dlaczego trauma wraca jako flashback, a nie zwyczajne wspomnienie? Dlaczego „nie chce odejść” przez lata? Model dwóch systemów pamięci wyjaśnia, czemu trauma wymaga innego sposobu pracy niż zwykle trudne wspomnienie.

CZAS: 15 min — przeczytanie Po pierwszej diagnozie

ŹRÓDŁO: van der Kolk (2014); Brewin (2014, dual representation theory)

JAK UŻYWAĆ

Brewin (2014) opisał, że **mamy dwa systemy pamięci dla zdarzeń**: pamięć *autobiograficzną werbalną* (VAM) — uporządkowaną w czasie, opisaną słowami, dostępną świadomie („to było wtedy, tam, w taki sposób”) oraz pamięć *sensoryczną sytuacyjną* (SAM) — zapisaną w obrazach, dźwiękach, doznaniach cielesnych, emocjach, bez czasu i języka. W normalnych zdarzeniach oba systemy współpracują. W traumie układ nerwowy jest **przeciążony** — VAM zostaje wyłączona, SAM zapisuje wszystko bez integracji. Skutek: wspomnienie traumy jest jak *żywe doświadczenie*, nie opowieść. Nie ma „wtedy”, jest „teraz”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

To wyjaśnia **wszystkie cztery klastry PTSD**. Intruzje to *nieuporządkowane fragmenty SAM* wdzierające się w teraźniejszość. Unikanie to *logiczna odpowiedź* na materiał, który czuje się jak realne zagrożenie. Negatywne przekonania wynikają z *braku spójnej narracji* — pacjent „wie”, że trauma była dawno, ale ciało jej tak nie pamięta. Nadmierna czujność to *nieintegrowana SAM* ciągle sygnalizująca zagrożenie. **Leczenie** polega na *integracji SAM z VAM* — przeniesieniu wspomnienia z systemu sensorycznego do narracyjnego, gdzie można je „odłożyć” w czasie. Terapie ekspozycyjne (PE, EMDR, CPT) działają właśnie poprzez ten mechanizm: ponowne, kontrolowane przetwarzanie traumy aż do jej zintegrowania w autobiografię.

01



Dwa systemy pamięci — porównanie

PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA (VAM)

zwyczajna pamięć

Forma: słowa, narracja, historia z początkiem, środkiem, końcem

Czas: wyraźna oś — „to było 5 lat temu, na wakacjach”

Miejsce: kontekst — gdzie, z kim, w jakich okolicznościach

Dostęp: dobrowolny, możliwy do opowiedzenia

Charakter: wspomnienie czuje się *dawne*

PAMIĘĆ SENSORYCZNA (SAM)

pamięć traumatyczna

Forma: obrazy, dźwięki, zapachy, doznania ciała, emocje

Czas: brak osi — wszystko czuje się jak *teraz*

Miejsce: brak kontekstu — fragmenty bez tła

Dostęp: mimowolny, wywołany przez sensorykę

Charakter: wspomnienie czuje się *żywe*

02



Dlaczego mózg działa tak w traumie

W NORMALNYCH ZDARZENIACH

Hipokamp porządkuje informacje w czasie i przestrzeni. Kora przedczołowa nadaje znaczenie. Wspomnienie zostaje *zintegrowane* jako element autobiografii.

W TRAUMIE

Ciało migdałowe *dominuje* (alarm). Hipokamp pod wpływem skrajnego stresu i kortyzolu *wyłącza się częściowo*. Kora przedczołowa też. Wspomnienie nie zostaje zintegrowane — pozostaje surowe.

03 Jak rozpoznać, którego typu pamięć — sprawdzenie

Każde wspomnienie — także trudne — ma swój odcień. Niektóre są mieszanką obu typów. Sprawdź siebie:

SYGNAŁY PAMIĘCI ZINTEGROWANEJ

- ☐ Pamiętam datę lub okres
- ☐ Pamiętam, gdzie byłem/-am
- ☐ Mogę opowiedzieć historię z początkiem i końcem
- ☐ Wspomnienie czuje się „przeszłe”
- ☐ Mogę myśleć o tym i czuć smutek/żal, ale nie panikę

SYGNAŁY PAMIĘCI TRAUMATYCZNEJ

- ☐ Fragmenty bez kontekstu (jeden obraz, jeden dźwięk)
- ☐ Brak ciągłości — „nie pamiętam, co było potem”
- ☐ Reakcja somatyczna podczas wspominania (tętno, pot)
- ☐ Wspomnienie czuje się „jak teraz”
- ☐ Trudność opowiedzenia w pełnym ciągu zdań

04 Jak terapia integruje pamięć

1 • STABILIZACJA

Najpierw *rozszerzenie okna tolerancji* i bezpieczne miejsce. Bez tego praca z trudnym materiałem zalewa. To okres budowy fundamentów — tygodnie do miesięcy.

2 • KONTROLOWANE PRZYWOŁYWANIE

W bezpiecznym kontekście (terapia) wspomnienie zostaje przywołane — z hipokampem i korą przedczołową *online*. Dzieje się to powoli, w trzeciej osobie czasu lub stopniowo bliżej. EMDR, PE, narrative exposure — różne drogi do tego samego celu.

3 • INTEGRACJA

Wspomnienie zostaje *przepisane* w pamięci autobiograficznej. Powstaje narracja: „*To wydarzyło się wtedy. Skończyło się. Jestem teraz.*” Wspomnienie **nie znika** — staje się elementem przeszłości, którego można dotknąć bez paniki.

Klucz: celem terapii PTSD *nie jest* zapomnienie traumy ani „przepracowanie do końca”. Cel jest węższy i precyzyjniejszy: **integracja** — przeniesienie wspomnienia z systemu sensorycznego do autobiograficznego. Po skutecznej terapii pacjenci raportują: „*pamiętam, co się stało, ale to teraz historia, nie scena, w której wciąż jestem*”. Ta różnica jest neurobiologiczna, mierzalna w aktywności hipokampa i kory przedczołowej (Lanius i wsp. 2010). Wspomnienie traumy nie znika — przestaje być teraźniejszością.